

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Акушерство на линии

Кровотечения, разрывы, гипертензия, ТЭЛА и решение «рожать
здесь или везти»

По практическому занятию на Центральной подстанции СМП Москвы (август 2026) и
Алгоритмам СМП 2025, раздел 9.

Эпизоды, которыми лектор иллюстрировал темы, оставлены внутри этих тем и
обезличены.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.5 · 23 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Практическое занятие на Центральной подстанции разбирало не акушерство «от А до Я», а развилки линии: что везти сразу, что согласовывать через акушерский пункт, когда принимать роды на месте. Ниже сохранён порядок тем занятия. То, что лектор называл кодами, фразами и именами приёмов, оставлено как было сказано; механизмы и объём помощи дописаны так, чтобы заметки читались связным текстом, а не списком. Если на линии нужна экстренная акушерская помощь, на занятии формулировка была короткой: «**у нас срочно**».

Аномальные маточные кровотечения

Аномальное маточное кровотечение (АМК) — кровотечение из полости матки, которое отклоняется от нормального менструального цикла по объёму, длительности, регулярности или частоте. Термин сменил устаревшее «дисфункциональное маточное кровотечение»: то название предполагало гормональную причину после исключения органики, чего на линии установить нельзя.

По Алгоритмам СМП 2025 (N92, N93, N95) аномальное маточное кровотечение — показание к эвакуации: катетеризация вены, транексамовая кислота 1000 мг внутривенно, транспортировка на носилках. При шоке объём тот же, что при геморрагическом шоке.

На занятии отдельно разобрана рабочая развилка, которой в алгоритме нет одной строкой. Скудные мажущие выделения без признаков кровопотери не закрываются как неотложное кровотечение. Это может быть патология эндометрия, перименопаузальное кровотечение и другие состояния, связанные с циклом.

Акушерский пункт — консультативная линия станции: бригада звонит туда, акушеры перезванивают сами и говорят, что делать дальше. Тогда звонят на пункт и ждут этого звонка: решение задаёт пункт, не бригада. Код, которым на занятии называли эту группу, — 2885, N90.8 («другие уточнённые состояния, связанные с менструальным циклом»). В алгоритме госпитализируемые кровотечения стоят под N92-N93 и N95; при расхождении приоритет у справочника станции и у алгоритма.

Смысл развилки не в том, чтобы «не возить мазню», а в том, чтобы не смешивать два разных решения. Опасное кровотечение — это эвакуация и транексам. Скудные выделения без кровопотери — это не «ничего», а звонок на пункт.

Патология яичника

Алгоритм держит апоплексию, разрыв кисты и перекрут под одной строкой (N83). На линии это один живот и одно решение — эвакуация; различия нужны затем, чтобы не принять одно за другое и не ждать «типичного дня цикла».

Апоплексия яичника

Апоплексия яичника — острое кровоизлияние в ткань яичника с возможным нарушением целостности капсулы и кровотечением в брюшную полость. Это кровоизлияние в паренхиму, а не просто вскрытие полости кисты, хотя оба события могут совпасть.

На занятии называли три клинических варианта: **болевого, анемического и смешанный**. Это не три разных болезни, а три способа, которыми одно и то же событие доходит до бригады. В болевом варианте доминирует боль при устойчивой гемодинамике. В анемическом — картина кровопотери: бледность, тахикардия, падение давления, слабость. Смешанный соединяет оба ряда.

Боль наступает внезапно и чаще односторонняя. Иррадиация идёт в крестец, копчик, нижние конечности — туда, куда отдают тазовые афференты, а не «строго над яичником». Эпизод возможен на фоне полного благополучия, в том числе среди ночи:

женщина просыпается от резкой боли, хотя вечером ничего не предвещало. Срок цикла не обязан быть серединой. Апоплексия случается в любую фазу; чаще кровоточит богато васкуляризованное жёлтое тело в лютеиновую фазу, но ждать «четырнадцатый день» как условие диагноза нельзя.

Овуляторный синдром (mittelschmerz) — кратковременная односторонняя боль в середине цикла, связанная с разрывом фолликула при овуляции, без кровопотери и без картины внутрибрюшного кровотечения. На занятии его называли прямо как дифференциал. Там боль короче, гемодинамика не нарушена, исследование живота не даёт картины внутрибрюшного кровотечения. Апоплексия отличается не «наличием боли в середине цикла», а тем, что боль либо держится, либо сопровождается признаками кровопотери.

Почему справа бывает чаще, чем слева: правая яичниковая артерия отходит от аорты под более крутым углом, давление в ней выше; левый яичник частично фиксирован сигмой. Для линии это не меняет маршрута. Меняет другое: наружного кровотечения может не быть вовсе. Кровь идёт в брюшную полость, простыни сухие, а женщина бледнеет. При крови в полости, пока ещё нет перитонита, живот может оставаться мягким, но болезненным (симптом Куленкампа). При массивном излитии кровь достигает диафрагмы и даёт боль в плече (симптом Кера).

Перекрыт яичника

Перекрыт яичника (торсия) — поворот яичника вокруг сосудистой ножки с пережатием сосудов, ишемией и угрозой некроза. Часто перекачивается весь придаток: яичник, труба и киста вместе. Киста смещает центр массы и облегчает поворот при движении, смене положения, нагрузке.

Справа перекрыт встречается чаще: правая подвешивающая связка длиннее, яичник подвижнее; слева сигма ограничивает ход. Яичник имеет двойное кровоснабжение — яичниковая артерия от аорты и ветвь маточной артерии. Поэтому доплер, который «видит» кровоток, перекрыт не исключает: один источник может быть пережат, второй ещё работает; перекрыт может быть перемежающимся; на ранней стадии сдавливаются вены, а артерии ещё пульсируют.

Клиника: внезапная односторонняя боль волнами (перекрыт и частичный раскрут), почти всегда тошнота и рвота — висцеральный вагусный ответ, которого при апоплексии обычно меньше. Лихорадки может не быть или она субфебрильная. Перитонеальных знаков нет, пока нет некроза. Окно до необратимой гибели ткани при полном перекрытии — около шести-восьми часов. На линии это не «подождать утро и сделать УЗИ», а эвакуация с тем же кодом N83.

Киста яичника и её разрыв

Киста яичника — полостное образование в яичнике, заполненное жидкостью или иным содержимым (серозным, геморрагическим, эндометриоидным, дермоидным). Сама по себе киста на линии вызов не закрывает: она — фон для перекрытия и для разрыва.

Разрыв кисты — нарушение целостности стенки кисты с излитием содержимого в брюшную полость. Это механическое вскрытие полости, а не кровоизлияние в паренхиму. Состояния перекаываются и на догоспитальном этапе не разделяются надёжно — и не должны задерживать эвакуацию.

Боль при разрыве внезапная, острая и после пика может ослабеть: полость декомпрессировалась. Тяжесть задаёт содержимое. Серозная киста даёт раздражение брюшины и может на этом остановиться. Геморрагическая ведёт себя как апоплексия: кровь в животе, риск шока. Эндометриоидная даёт выраженную боль и перитонизм.

Дермоидная (зрелая тератома) изливает жир и волосы — химический перитонит, клиника острого живота без наружного кровотечения.

	Апоплексия	Перекрут	Разрыв кисты
Что происходит	Кровоизлияние в ткань яичника	Поворот вокруг ножки, ишемия	Вскрытие полости кисты
Боль	Внезапная, держится	Внезапная, волнами	Внезапная, после пика может ослабеть
Рвота	Не обязательна	Почти всегда	Не обязательна
Наружное кровотечение	Обычно нет	Нет	Нет
Чем кончается без операции	Гемоперитонеум, шок	Некроз придатка	Раздражение брюшины или шок — по содержимому

По алгоритму (N83: апоплексия, разрыв или перекрут кисты) для всех трёх — венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг или этамзилат 500 мг, эвакуация на носилках. Транексам имеет смысл, когда есть кровотечение в полость; при «чистом» перекруте без гемоперитонеума он не лечит ишемию. Маршрут от этого не меняется.

Внематочная беременность

Внематочная беременность — имплантация плодного яйца вне полости матки. Чаще всего это труба; реже — яичник, шейка, рубец, брюшная полость. Труба, в отличие от матки, почти не имеет запаса на растяжение: нет полноценного подслизистого слоя, мышечная стенка тонкая. Матка вмещает плод. Труба не вмещает даже небольшое плодное яйцо — отсюда неизбежность либо трубного аборта, либо разрыва, если беременность прогрессирует в трубе.

На занятии делили состояние на две большие группы: **прогрессирующая** и **нарушенная**.

Прогрессирующая внематочная беременность — плодное яйцо имплантировано вне матки, труба ещё цела. Периодически повторяющиеся выделения и боли. Заподозрить можно по анамнезу и первому дню последней менструации, но задержки менструации нет почти у половины пациенток: кровянистые выделения принимаются за «очередные месячные». Классическая триада «аменорея + боль + мазня» собирается не всегда; ждать её целиком — способ опоздать. Лечение на догоспитальном этапе алгоритм не требует; эвакуация обязательна. Пока труба цела, катастрофы ещё нет, но это не повод оставлять женщину дома.

Нарушенная внематочная беременность — целостность трубы уже потеряна. Два механизма.

Трубный аборт — плодное яйцо отслаивается и через фимбриальный конец сбрасывается в брюшную полость, стенка трубы при этом не рвётся на всём протяжении. Стертая картина: выделения, болевой синдром, который сам по себе затихает. Женщина может ходить так до месяца. Это не «прошло». Кровь течёт медленно, боль волнообразная, шока может не быть днями. За это время в животе накапливается гемоперитонеум, который на линии ещё не читается как «кинжал».

Разрыв трубы — стенка трубы теряет целостность, кровотечение становится массивным за минуты. Обморочное состояние, холодный липкий пот, резкая кинжальная боль. При осмотре патология в нижних отделах живота. По алгоритму: пульсоксиметрия,

венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг, эвакуация на носилках; при шоке — протокол геморрагического шока.

Живот осматривается целиком, не только «над лоном». На занятии это было сказано отдельно и жёстко: смотреть животы. Внематочная, тяжёлая презкламписия и разрыв матки по дну разбирались как состояния, которые дают картину острого живота. На занятии эту картину называли **КИНЭ** — клиника, неотличимая от острого хирургического живота, пока диагноз не разобран. Если клиника удерживает оба диагноза — в карте фиксируется двойной, а не «более удобный» один. Звонок на акушерский пункт при любой из этих картин у беременной или у женщины с возможным сроком.

Тромбоэмболия лёгочной артерии при беременности

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — закупорка ветвей лёгочной артерии тромбом, чаще эмболом из вен таза или нижних конечностей. **Субмассивная ТЭЛА** — эмболия без системной гипотензии: компенсация ещё держит артериальное давление, нагрузка на малый круг уже есть.

Беременность — тромбогенное состояние с первого триместра, не «с третьего». Растущая матка ещё не обязана сдавливать вены, чтобы свертываемость уже сдвинулась: меняются факторы свёртывания, венозный застой в тазу появляется рано, эмбол может уйти из тазовых и проксимальных вен нижней конечности. Поэтому боль в ягодичной или тазовой области у беременной с дыхательной жалобой — не «радикулит в придачу», а возможный след источника эмбола.

Кровохарканье, необъяснимая одышка, тахикардия, обмороки складываются в сосудистый диагноз, а не в «простуду». Мукалтин на кровохарканье не отвечает: это отхаркивающее, а не лечение тромбоэмболии и не повод закрыть дыхательную жалобу как катаральную.

Электрокардиограмма при субмассивной тромбоэмболии часто не показывает перегрузку правых отделов. Классика «S1Q3T3» — поздняя и необязательная находка. Стабильное артериальное давление означает лишь то, что компенсация ещё держит системное давление; оно не измеряет тромботическую нагрузку. Кардиопульту передаётся клиника целиком, включая обмороки и кровохарканье, а не только «плёнка без изменений».

Эпизод с занятия. Беременность 10 недель. Кровохарканье, слабость, были обмороки, боль в ягодичной области. Гемодинамика стабильна. SpO₂ 95 %, частота дыхания 22 в минуту, синусовая тахикардия 110, электрокардиограмма без ишемических изменений. В медцентре назначен мукалтин. В инфекционном стационаре — судороги и клиническая смерть. Диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии. Судороги и остановка здесь — исход эмболии, а не «нейроинфекции», под которую пациентку успели маршрутизировать. На занятии формулировка была прямой: таких тромбоэмболий очень много.

Гипертензивные расстройства

Три сущности, которые не заменяют друг друга. Граница по сроку — **20 недель**.

Хроническая артериальная гипертензия — повышение артериального давления, которое существовало до беременности или выявлено до 20 недель. Беременность его застала, а не создала.

Гестационная артериальная гипертензия — повышение давления после 20 недель без критериев презкламписии: нет протеинурии и нет признаков органного поражения.

Преэклампсия — гипертензия после 20 недель плюс протеинурия или признаки поражения органов (головная боль, зрительные нарушения, боль в эпигастрии или правом подреберье, олигурия, отёк лёгких, HELLP). Возможна послеродовая форма.

Эклампсия — судороги у беременной или родильницы на фоне преэклампсии, не объяснимые другой причиной.

HELLP-синдром — гемолиз, повышение печёночных ферментов и тромбоцитопения; клинический вход на линии — боль в эпигастрии или правом подреберье у беременной с гипертензией.

Состояние	Срок появления	Суть
Хроническая артериальная гипертензия	До 20 недель либо существовала ранее	Гипертензия, которую беременность застала, а не создала
Гестационная артериальная гипертензия	После 20 недель	Повышение давления без критериев преэклампсии
Преэклампсия	Обычно после 20 недель, возможна послеродовая	Гипертензия плюс органное поражение; на линии — по давлению и симптомам

Преэклампсия начинается не с «плохой наследственности по давлению», а с плаценты. В норме трофобласт перестраивает спиральные артерии матки в широкие низкорезистентные сосуды. Если вторая волна инвазии срывается, артерии остаются узкими, плацента ишемизируется и выбрасывает в кровь матери антиангиогенные факторы и обломки синцитиотрофобласта. Следствие — генерализованное повреждение эндотелия: вазоспазм, протеинурия, отёк, ишемия печени и мозга. Артериальное давление при этом — следствие спазма, а не «компенсация ради плода». Поэтому снижать его ниже целевого нельзя: маточно-плацентарный кровоток не имеет собственной ауторегуляции и падает вместе с системным давлением.

Объём помощи на линии задаёт не одно число на манжете.

Картина	По Алгоритмам СМП 2025
Умеренная преэклампсия, АД 140-160 / 90-110, без головной боли, зрительных нарушений, тошноты, рвоты, боли в эпигастрии или правом подреберье	Нифедипин 10 мг внутрь . Сублингвально противопоказан: резкий спад давления бьёт по плацентарной перфузии
Та же цифра АД, но есть любой из перечисленных симптомов	Нифедипин 10 мг внутрь и магния сульфат: 4000 мг (16 мл) внутривенно за 10-15 мин, затем 1000 мг/ч
Тяжёлая: АД $\geq$ 160/110 независимо от симптомов	Тот же объём, что при умеренной с симптомами
Целевое давление	САД 130-150, ДАД 80-95 мм рт. ст. Ниже 100/80 не снижать

На занятии формулировка совпала с алгоритмом. «Только нифедипин» — это умеренная преэклампсия без субъективной симптоматики. Головная боль, нарушение зрения, головокружение, боль в эпигастрии при давлении «ещё не 160» уже переводят случай в тяжёлый по объёму помощи — нифедипин плюс магния как профилактика судорог.

Магния сульфат здесь не антигипертензивный препарат. Он блокирует избыточное возбуждение NMDA-рецепторов и снижает риск эклампсии. Давление снижают нифедипином; судороги предупреждает магния. Смешивать эти роли нельзя:

«капнуть магнезию вместо нифедипина» гипертензию не лечит, а «только нифедипин» при симптомах не закрывает судорожный риск.

Боль в эпигастрии или правом подреберье у беременной с гипертензией — не гастрит по умолчанию. Это один из клинических входов в HELLP: гемолиз, рост печёночных ферментов, падение тромбоцитов. На линии лабораторного подтверждения нет; есть боль, которая уже меняет объём помощи.

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) — отделение плаценты, расположенной вне области внутреннего зева, от стенки матки до рождения плода. На занятии говорили, что форм «очень много»: тотальные, субтотальные и другие по площади. Для линии важнее не процент площади, а геометрия: куда уходит кровь и есть ли боль.

Ретроплацентарная гематома — скопление крови между плацентой и стенкой матки. Разрыв сосудов в decidua basalis даёт эту гематому. Она растёт, отслаивает плаценту дальше, газообмен плода падает, мать теряет кровь — иногда всю внутрь, без наружных выделений.

Краевая отслойка — отслойка с края плаценты: кровь находит путь наружу по оболочкам, болевого синдрома может не быть.

Центральная отслойка — отслойка в центре, без сообщения с краем: наружных выделений нет, боль выражена, матка напряжена.

Смешанная отслойка — есть и ретроплацентарная гематома, и наружное кровотечение.

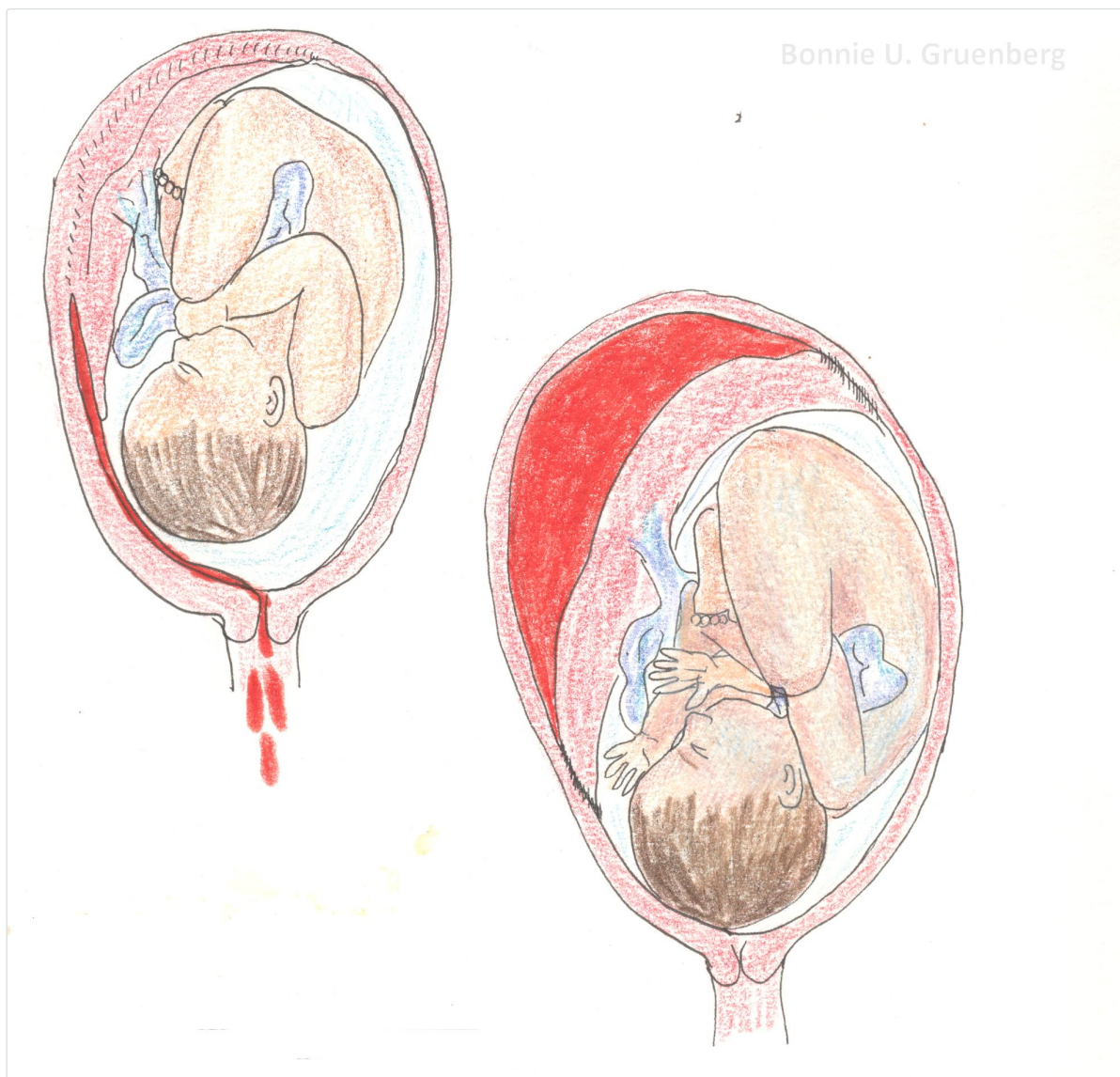


Рис. 1. Сверху — краевая (revealed) отслойка: кровь находит путь наружу. Снизу — центральная (concealed): ретроплацентарная гематома без выделений. Смешанная форма сочетает оба пути и на рисунке не показана. Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Форма	Кровь снаружи	Боль	Что происходит
Краевая	Есть наружное кровотечение	Болевого синдрома может не быть	Отслойка с края, кровь стекает по оболочкам
Центральная	Выделений нет	Выраженная боль	Формируется ретроплацентарная гематома; матка напряжена, «деревянная»
Смешанная	Есть и гематома, и наружное кровотечение	Боль плюс выделения	Сочетание обоих путей

Объём наружной крови не равен объёму кровопотери. При центральной отслойке женщина бледнеет и входит в шок при «сухих» простынях. **Матка Кувелера** — пропитывание миометрия кровью из ретроплацентарной гематомы: матка становится напряжённой, «деревянной», теряет способность сокращаться. Влагалищное

исследование противопоказано: палец не покажет геометрию отслойки, зато может усилить кровотечение, если одновременно есть предлежание плаценты.

Предлежание плаценты — расположение плаценты в нижнем сегменте с перекрытием или близостью к внутреннему зеву. На занятии его отдельной темой не разбирали; запрет влагалищного исследования при кровотечении в третьем триместре держится именно из-за этой возможности.

По алгоритму (О45): венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг, эвакуация на носилках.

Разрыв матки

Разрыв матки — нарушение целостности стенки матки во время беременности или родов. На занятии разделяли «тихий» разрыв по рубцу и свершившийся разрыв.

Гистохимический разрыв, расхождение рубца — постепенное расхождение рубца без картины острого живота. Может идти бессимптомно. Возможны покалывания.

Симптом ниши — локальное западение или дефект в области рубца при пальпации. Область рубца осматривается прицельно, сердцебиение плода выслушивается. Клиники «кинжала и шока» может не быть: рубец расходится постепенно, плод по частям пролабирует в дефект, гемодинамика ещё держится.

Эпизод с занятия. Женщина впервые пришла становиться на учёт в 27 недель. В разошедший рубец на матке провалилась пяточка плода. Ногу сохранить не удалось: шёл некроз. До этого не было ни кинжальной боли, ни шока. Катастрофа уже свершилась анатомически, пока карта ещё могла выглядеть как «поздняя постановка на учёт».

Свершившийся разрыв — полная потеря целостности стенки: дикая кинжальная боль, шок. Предлежащая часть может уйти вверх: то, что только что стояло над входом в таз, перестаёт пальпироваться там же — плод частично или полностью уходит в брюшную полость. Схватки могут оборваться.

Симптом Вастена — головка не прижимается ко входу в таз и «нависает» над лоном при несоответствии размеров головки и таза. На занятии его называли отдельно: это маркер препятствия и угрозы разрыва, а не доказанный разрыв. Ждать кинжала, чтобы заподозрить угрозу, не нужно.

По алгоритму (О71: угрожающий, начавшийся, свершившийся): пульсоксиметрия, венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл; при начавшемся и свершившемся — транексамовая кислота 1000 мг; эвакуация на носилках.

Роды: осмотр и решение «здесь или в стационар»

Приёмы Леопольда

Приёмы Леопольда — четыре наружных приёма пальпации беременной матки. Они отвечают на четыре вопроса: что в дне, где спинка, что предлежит, насколько предлежащая часть вошла во вход в таз.

Первый приём — обе ладони на дне матки: там головка или таз. Второй — руки по бокам: спинка с одной стороны, мелкие части с другой. Третий — захват предлежащей части над лоном одной рукой: головка это или таз, и насколько она ещё баллотируется. На занятии отдельно сказано: третий приём может вызвать боль, выполняется осторожнее. Четвёртый — обе руки направлены к тазу, определяют отношение предлежащей части ко входу.

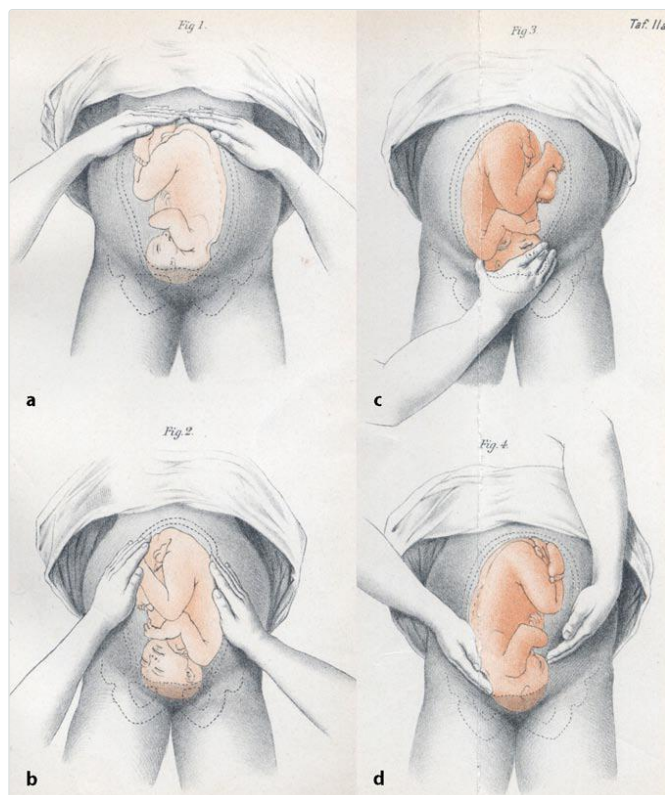


Рис. 2. Приёмы Леопольда. Fig. 1 — дно матки. Fig. 2 — стороны матки (спинка и мелкие части). Fig. 3 — предлежащая часть над входом в таз, одной рукой (приём может быть болезненным). Fig. 4 — отношение предлежащей части ко входу в таз, руки направлены к тазу. Christian Gerhard Leopold, 1894; общественное достояние.

Наружные приёмы не заменяют решение «рожать здесь или везти». Они отвечают, что предлежит и где это стоит. Стоит ли головка уже в полости или в выходе — на занятии решали методом Пискачека.

Метод Пискачека

Метод Пискачека — наружный приём определения, достигла ли головка полости или выхода таза: давление двумя пальцами через большую половую губу параллельно влагалищной трубке, без входа в просвет влагалища. Решение «рожать на месте или везти» завязано на этот метод, а не на ощущение «уже не успеем». Это не влагалищное исследование и не одноимённый признак ранней беременности (асимметрия матки, Piskaček, 1899).

Положение. Роженица лежит на спине на предродовой кровати. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах и разведены. Исследующий садится справа.

Техника. Второй и третий пальцы обернуты стерильной марлей. Кончики этих пальцев ставятся по боковому краю правой большой половой губы. Давление — вглубь, параллельно влагалищной трубке, до встречи с головкой. Пальцы в просвет влагалища не входят.

Как читать. Пальцы достигают головки, если она уже в полости или в выходе таза — метод положительный: роды принимаются на месте. Сначала туалет роженицы, смена подкладной пелёнки и нательного белья, затем пособие. Если головка не встречена — эвакуация.

Открытой лицензионной схемы метода нет.

Домашние роды

Домашние роды — роды вне родильного дома, которые бригада принимает на месте. На станции они закрываются кодом, который на занятии называли 1641 (в алгоритме — 080, «домашние роды» / «роды вне родильного дома»). Если роды принимаются на месте, объём — по разделу «Домашние роды»: аускультация сердцебиения плода, венозный доступ, акушерское пособие, лоток под половые пути, окситоцин 10 МЕ внутримышечно в бедро после рождения ребёнка, осмотр последа и доставка его в роддом, контроль каждые 15 минут в течение двух часов.

Биомеханизм родов

Биомеханизм родов — последовательность движений, которыми предлежащая часть проходит костный таз. На занятии блок назван отдельно: прежде чем оказывать пособие, нужно понимать, какое движение головка уже совершает. Пособие не «вытаскивает» ребёнка. Оно не мешает тому сгибанию, повороту и разгибанию, которым головка проходит таз, и удерживает промежность, пока эти движения идут.

Передний вид затылочного предлежания — головка предлежит затылком кпереди; это наиболее частый и наиболее выгодный вариант головных родов. Головка входит во вход в таз малым косым размером. Сгибание прижимает подбородок к груди — проходящий размер становится меньше. В полости таза головка совершает внутренний поворот: затылок идёт к лону, стреловидный шов — из косого размера в прямой. В выходе таза головка разгибается: рождаются затылок, темя, лоб, лицо, подбородок. Затем следует наружная ротация — головка поворачивается лицом к бедру матери, и в прямой размер выхода встают плечики. Переднее плечико выходит из-под лона, заднее — над промежностью, за ними рождается туловище.

Если сгибание срывается, головка идёт большим размером и рвёт промежность или застревает. Если внутренний поворот не завершён, плечики стоят в косом размере, когда им уже нужен прямой. Пособие при переднем виде затылочного предлежания как раз удерживает эти два момента: не даёт головке разогнуться слишком рано и не тянет туловище, пока плечики не встали в размер выхода.

Пособие в родах

Акушерское пособие — приём руками, который сопровождает рождение предлежащей части и не заменяет схватки тракцией. На занятии перечислены приёмы, которые нужно называть по имени. Ниже — роль каждого и та последовательность, которая из этого имени следует. Это не замена руками отработанному занятию на фантоме.

Передний вид затылочного предлежания

Типичные головные роды: защита промежности и сдерживание разгибания головки, затем рождение переднего и заднего плечика. Правая рука защищает промежность. Левая лежит на головке и сдерживает слишком быстрое разгибание: головка должна родиться постепенно — лоб, лицо, подбородок, а не «выстрелить» наибольшим размером. Когда головка родилась, проверяют обвитие. Свободную петлю снимают через голову; тугую пережимают двумя зажимами и пересекают между ними.

Дальше головка совершает наружный поворот. Переднее плечико выводят, мягко направляя головку вниз, к промежности, пока плечико не выйдет из-под лона. Заднее — направляя головку вверх. Тянуть ребёнка на себя вдоль оси туловища нельзя: так срывается поворот плечиков и рвётся промежность.

Тазовое предлежание — предлежащая часть — таз или ножка плода; головка идёт последней. На линии это не «другие роды того же пособия». Пока тело не родилось до пупка, пособие не оказывается: гравитация и схватки работают сами, тракция запрокидывает ручки и разгибает последующую головку.

Чисто ягодичное предлежание — предлежат ягодичы, ножки разогнуты вдоль туловища, стопы у лица.

Ножное предлежание — внизу одна или обе ножки, ягодичы ещё выше.

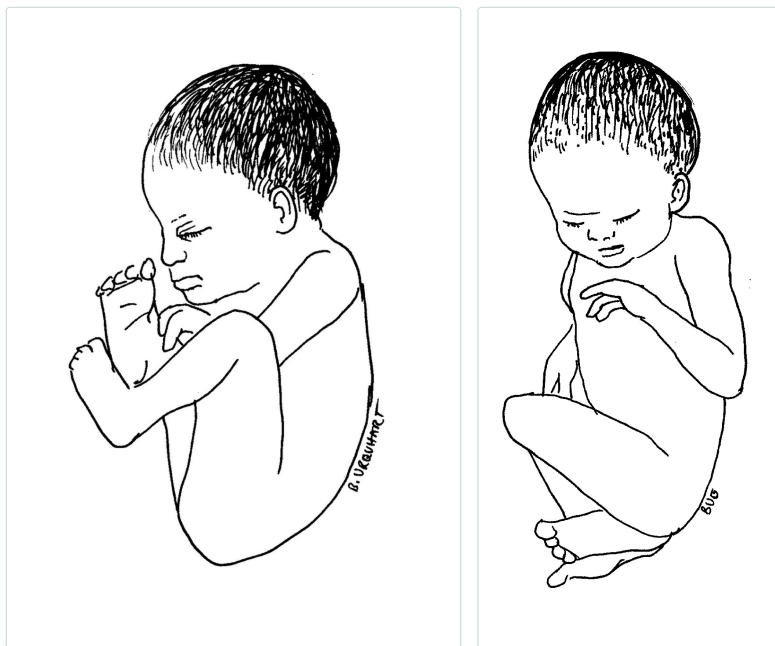


Рис. 3. Слева — чисто ягодичное (frank) предлежание: бёдра согнуты, голени разогнуты, стопы у лица; это поле для пособия Цовьянова I. Справа — ножное: внизу ножка, таз ещё выше; это поле для Цовьянова II.
Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Пособие Цовьянова I — при чисто ягодичном предлежании ножки удерживают прижатыми к туловищу, пока не родится туловище до нижнего угла лопаток. Если ножки выпустить раньше, они перестают расширять родовой канал для последующей головки, и головка встречает недостаточно подготовленную шейку.

Пособие Цовьянова II — при ножном предлежании ножки удерживают до рождения ягодич, чтобы предлежание по возможности приблизилось к ягодичному. Если дать ножкам родиться слишком рано, за ними пойдёт туловище через неподготовленный канал, а головка снова застрянет.

По алгоритму при тазовом предлежании пособие не оказывается до самостоятельного рождения ребёнка до уровня пупка. Тянуть ребёнка на себя запрещено.

Тело, которое уже родилось, пока головка ещё внутри, быстро стынет. Холод провоцирует вдох, когда лицо ещё в родовых путях, — аспирация. Поэтому родившуюся часть укрывают.



Рис. 4. Тазовое предлежание: туловище родилось, головка ещё внутри. Руки удерживают бёдра, спинка повернута кпереди — исходное положение и для классического пособия, и для приёма Ловсета. Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Классическое ручное пособие

Классическое ручное пособие — освобождение запрокинутых за головку ручек после рождения туловища до нижнего угла лопаток. Туловище отклоняют, входят к задней ручке, выводят её, затем ротируют туловище и освобождают вторую.

Приём Ловсета — ротационный вариант той же задачи: туловище поворачивают на 180° так, чтобы заднее плечико стало передним и вышло из-под лона, затем поворот в обратную сторону. На занятии блок назван «классическое пособие»; Ловсет в алгоритмах стоит рядом как именно ротационный вариант.

Морисо-Левре-Ляшапель

Приём Морисо-Левре-Ляшапель (в алгоритме — Морисо-Смелли-Вайт) — пособие при задержке последующей головки: сгибание головки пальцем на нижней челюсти и давлением на затылок со стороны плеч, без тракции ребёнка на себя. Это один манёвр с разными эпонимическими рядами. Последующая головка не всегда рождается сама.

Ребёнок лежит верхом на предплечье, животом вниз. Указательный палец одной руки идёт в рот и давит на нижнюю челюсть вниз — головка сгибается. Два пальца другой руки лежат на плечах и усиливают сгибание со стороны затылка. Согнутая головка проходит малым косым размером. Разогнутая — большим, и застревает. Ребёнка не тянут на себя: тракция разгибает шею и срывает как раз то сгибание, ради которого приём существует.

Открытой современной схемы именно этого захвата с лицензией, которую можно положить в файл, нет. Исторические гравюры Морисо и Смелли показывают идею сгибания последующей головки, но не современную укладку рук. Открытого видео приёма, которое можно перепубликовать, тоже нет: учебные ролики Global Health Media для Европы и России требуют отдельной лицензии, а фильм Wellcome 1966 года остаётся чужой собственностью. Общественное достояние есть у американского учебного фильма *Emergency Childbirth* (U.S. Navy, 1961; Internet Archive) — там экстренные головные роды, не Цовьянов и не Морисо.

Выпадение пуповины

Выпадение пуповины (пролапс) — петля пуповины оказывается ниже предлежащей части после излития вод и сдавливается между предлежащей частью и тазом. Кровоток к плоду прекращается; брадикардия и гибель считаются минутами, не часами. Ножное предлежание даёт это чаще: ножка не заполняет таз.

В родильном зале и в учебниках пособие выглядит так: рука во влагалище поднимает предлежащую часть **вверх от пуповины** и остаётся там до операционной. Это не «затолкнуть голову обратно в матку». Головку не вправляют и не разгибают. Её только разобщают с петлёй на несколько сантиметров. Пуповину не вправляют: манипуляции дают спазм сосудов. Выпавшую наружу петлю накрывают влажной тёплой салфеткой, без тракции. Пока рука занята, ту же разобщающую работу делает гравитация: коленно-локтевое положение или таз выше головы. Наполнение мочевого пузыря 300–500 мл через катетер — стационарный способ прижать предлежащую часть, если руку нужно освободить. Единственное лечение — экстренное кесарево сечение.

На занятии этот ручной подъём для линейной бригады закрыли: «голову руками отталкивать нельзя», «как вы это собираетесь делать — не выдумывайте». Алгоритм с этим совпадает по допуску, не по молчанию. В разделе 9 после излития вод

влагалищное исследование «для исключения выпадения петель пуповины» помечено **для АГБ**. Линейная бригада этого исследования в своём объёме не имеет.

Что остаётся на линии.

Потуги останавливают, на дно матки не дают. Роженицу кладут в колено-локтевое положение или с тазом выше головы — это и есть замена руке. Петлю не вправляют, не вытирают насухо и не тянут. Если она снаружи — влажная тёплая салфетка. Кислород, вена, аускультация сердцебиения плода. Эвакуация сразу, роддом предупреждают: выпадение пуповины, нужна операционная. Формулировка занятия — «у нас срочно».

Если на вызове есть акушерско-гинекологическая бригада, ручной подъём предлежащей части — её объём. Если метод Пискачака уже положительный и головка в выходе, это больше не транспортировка с пролапсом: роды принимаются на месте, и страница другая.

Источники

- Практическое занятие по акушерству, Центральная подстанция скорой медицинской помощи Москвы, август 2026 (рабочие формулировки линии: акушерский пункт, метод Пискачака, «у нас срочно», коды 2885 и 1641).
- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025), раздел 9 «Акушерство и гинекология»: N83, N92–N95, O00, O10–O16, O14, O15, O44, O45, O71, O80. Влагалищное исследование после излития вод «для исключения выпадения петель пуповины» в строке тазового предлежания помечено для АГБ.
- Клинические рекомендации: внематочная беременность; преэклампсия, эклампсия, гипертензивные расстройства во время беременности; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; роды вне стационара. Патология яичника (апоплексия, перекрут, разрыв кисты) — по конспекту ургентной гинекологии и строке N83 Алгоритмов СМП 2025.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
otsloyka_marginal_concealed.jpg	Краевая (revealed) и центральная (concealed) отслойка	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
leopold_1894.jpg	Четыре приёма Леопольда	Christian Gerhard Leopold, 1894; Leopold und Spörlin, <i>Arch Gynäkol</i> 45: 337–368; Wikimedia Commons, общественное достояние
breech_frank.jpg	Чисто ягодичное предлежание	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
breech_footling.jpg	Ножное предлежание	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
breech_povorot.jpg	Тазовые роды: туловище родилось, спинка кпереди	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Схемы метода Пискачека, Цовьянова и Морисо с открытой лицензией, которую можно положить в файл, не найдены. Сгенерированные схемы из версии 1.0 сняты ранее: на них были латинская транслитерация вместо кириллицы и неверное положение рук при третьем приёме Леопольда.

Выходные данные

Материал: «Акушерство на линии». Версия 1.5 от 23 августа 2026. Добавлен раздел о выпадении пуповины: ручной подъём подлежащей части — объём АГБ; на линии — положение, не вправлять петлю, экстренная эвакуация.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник. Рисунки Gruenberg остаются под CC BY-SA 4.0 и требуют указания авторства при любом дальнейшем использовании.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Коды повода (2885, 1641) приведены как рабочие формулировки занятия; при расхождении с действующим справочником станции приоритет у справочника и у Алгоритмов СМП.

О клинических эпизодах. Эпизоды рассказаны на занятии и обезличены: нет имён, дат, адресов, номеров карт и названий стационаров. Совпадения с чужой практикой возможны.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией.